

Objectifs :

- Définir les principaux termes utilisés en pharmacovigilance/matériovigilance
- Organisation et missions de la pharmacovigilance en France (connexions avec les structures européennes)
- Obligations des professionnels de santé en termes de pharmacovigilance
- Circuit d'élimination des médicaments

I) PHARMACOVIGILANCE

Définition pharmacovigilance : « Ensemble des procédures, méthodes ou techniques visant à surveiller, évaluer, prévenir et gérer le risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments, que ce risque soit potentiel ou avéré. Pour les médicaments mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit »

PHARMACOVIGILANCE	
Ensemble des procédures, méthodes ou techniques visant à surveiller, évaluer, prévenir et gérer le risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments, que ce risque soit potentiel ou avéré. Pour les médicaments mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit	
OBLIGATION DE DECLARATION	
• La pharmacovigilance repose avant tout sur le signalement des effets indésirables susceptibles d'être dus aux médicaments ou produits • Obligation de déclaration des professionnels de santé dès qu'ils soupçonnent un lien, même s'il n'est pas certain • Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou le pharmacien déclarent immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou à un produit dont ils ont connaissance • Que déclarer ? Toute suspicion : ○ d'effet indésirable médicamenteux ○ d'erreur médicamenteuse ○ de mésusage, d'abus, de surdosage ○ d'exposition professionnelle à un médicament ○ que l'effet soit connu ou non, qu'il soit grave ou non	
EFFET INDESIRABLE	Réaction nocive, non voulue à un médicament, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour le rétablissement , la rectification ou la modification d'une fonction physiologique.
EFFET INDESIRABLE GRAVE	Entraînant le décès ou mettant en jeu le pronostic vital ou entraînant une invalidité ou une incapacité significative ou entraînant/prolongeant une hospitalisation ou entraînant une anomalie ou malformation congénitale.
ELARGISSEMENT DEF EI	Couvre dorénavant les réactions nocives survenues dans toutes les situations d'utilisation (mésusage, abus, surdosage, erreurs médicamenteuses , absence d'effet thérapeutique, rumeurs, mauvaise observance, exposition professionnelle, rupture de la chaîne du froid...).
EFFET INDESIRABLE INATTENDU	Dont la nature, la gravité, l'effet, l'évolution, ne concordent pas avec le RCP
MESUSAGE	Utilisation intentionnelle et inappropriée d'un médicament ou d'un produit, non conforme à l'AMM ainsi qu'aux recommandations de bonnes pratiques (non conforme au RCP).
IMPUTABILITE	Analyse au cas par cas du lien de causalité entre la prise d'un médicament et la survenue d'un événement indésirable .
PHARMACOVIGILANCE EN FRANCE	
ROLE	• Le signalement des effets indésirables et le recueil des informations les concernant • L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention • Analyse de infos en prenant en compte les données disponibles concernant la vente, la délivrance et les pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients des médicaments et produits

	La réalisation de toutes études et travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments
ACTEURS	L'ANSM Le Comité technique (assure l'interface avec les réseaux de terrain) - Les Centres régionaux - Les membres des professions de santé, les entreprises ou organismes exploitant un médicament, ainsi que les PUI - Sans oublier les patients et les associations de patients
SYSTEME FRANCAIS	Autres pays EMA Laboratoires pharmaceutiques Ministère en charge de la Santé ansm Commission de réévaluation du bénéfice / risque Comité Technique de Pharmacovigilance Centres Régionaux de Pharmacovigilance Professionnels de santé Patients DECISION REEVALUATION DU B/R Émission d'avis Proposition de mesure(s) IDENTIFICATION DU RISQUE Analyse des signaux / alertes Enquêtes nationales / Suivis RECUEIL DES CAS Recueil/Evaluation /Imputabilité Production de signaux / alertes Expertises pour l'ANSM Information / Formation NOTIFICATION SPONTANEE 9 - Un réseau de 31 CRPV - L'emploi, par tous les spécialistes concernés, d'une méthode d'imputabilité commune imposant un contrôle de qualité des informations recueillies, de façon à pouvoir établir un score évaluant la relation de causalité entre un événement indésirable et un ou des traitements - La centralisation et l'évaluation de l'ensemble de ces données par l'ANSM
COMMISSION DU SUIVI B/R	Consultée si sont envisagés : - Une réévaluation du rapport B/R - Des modifications substantielles des AMM notamment sur les rubriques de sécurité figurant dans les RCP - Des modifications des conditions de prescription et de délivrance produits de santé L'élaboration ou la mise à jour de certains plans de gestion des risques de médicaments déjà autorisés (sauf médicaments psychoactifs) - La surveillance et le contrôle de certains dispositifs médicaux - Certains arrêts de commercialisation
EXIGENCES COMMUNAUTAIRES	Système de gestion de risque pour chaque médicament dont - Plans de gestion des risques (PGR) - Mesures de minimisation des risques (MMR) - Système de Pharmacovigilance Personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance - Tenue d'un dossier permanent du système de pharmacovigilance
PGR	Plan de PV renforcé qui permet dans une démarche proactive, de détecter et quantifier tout signal d'EI, mieux connaître le profil de sécurité d'emploi et minimiser les risques liés à utilisation d'un médicament informations manquantes lors de l'AMM notamment populations à risque surveillance du bon usage dans les conditions réelles d'utilisation

	● identification des pratiques s'éloignant du bon usage ● risque potentiel et risque connu Depuis 2005 (et renforcement en 2012) pour : ● Toute nouvelle substance, tout bio similaire, toute biothérapie ● Tout générique si problème identifié avec le princeps ● Extension d'AMM (dosage, voie, procédé de fabrication, indication, extension pédiatrie) ● A la demande des autorités compétentes en cas de signal de PV identifié à n'importe quelle étape de la vie du médicament
PHARMACOVIGILANCE DANS L'UE	
TEXTES COMMUNAUTAIRES	● Règlement UE du 15 décembre 2010 ● Directive UE du 15 décembre 2010 ● Les bonnes pratiques de pharmacovigilance
ACTEURS	● L' EMA = Système de PV au niveau communautaire ● Reproduit l'organisation française : recueil et validation décentralisés au niveau de chaque état membre, évaluation et avis et/ou décision centralisés au niveau européen ● Comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) : évalue les risques ainsi que les mesures de suivi et de gestion de ces risques ● Base de données : EudraVigilance database
MDTS SOUS SURVEILLANCE RENFORCEE	● Sur décision du PRAC ● Médicaments concernés : ○ nouvelle substance active ○ biologique (vaccin, médicament dérivé du sang) ○ bénéficie d'une autorisation conditionnelle (demande de données complémentaires) ○ études de sécurité post autorisation ● Symbole spécifique et mention (RCP, notice) ● Retrait de la liste après 5 ans
DECISIONS	● Retrait de lot ● Modification du RCP ● Modification du conditionnement ● Restriction de prescription, d'utilisation ● Suspension ou retrait de l'AMM

II) **MATERIOVIGILANCE**

MATERIOVIGILANCE		
	● Décret 15 janvier 1996 (modifié par décret en conseil d'Etat du 4 mars 1999) ● La matériovigilance concerne la surveillance /prévention des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux ● S'exerce sur les DM après leur mise sur le marché	
OBJECTIFS	● Eviter que ne se (re)produisent des incidents et risques d'incidents graves mettant en cause des DM, en prenant les mesures préventives et /ou correctives appropriées ● Elle comporte, notamment, le signalement, l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation des informations signalées, dans un but de prévention	
ACTEURS	ECHELON NATIONAL	ANSM

	ECHELON LOCAL • correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé • fabricants • quiconque ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident : les utilisateurs et les tiers
DOMAINE D'APPLICATION	• S'applique à tous DM notamment : ○ les consommables à usage unique ou réutilisables ○ les implants passifs ou actifs ○ les équipements • L'évaluation doit essayer de répondre aux questions suivantes : ○ le DM peut-il être en cause ? ○ le risque d'incident ou l'incident est-il grave ? ○ le risque d'incident ou l'incident est-il reproductible ?
OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES	Signalement obligatoire et sans délai : • D'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'autorité administrative • Tout rappel de dispositif du marché, motivé par une raison technique ou médicale Les autres événements indésirables peuvent être signalés selon une périodicité trimestrielle et de manière facultative
SURVEILLANCE APRES COMMERCIALISATION	• Pour chaque dispositif, les fabricants conçoivent, établissent, documentent, appliquent, maintiennent et mettent à jour un système de surveillance après commercialisation en fonction de la classe de risque et du type de dispositif • Le rapport périodique actualisé de surveillance (classes IIa, IIb, III) et le rapport sur la surveillance (classe I) font la synthèse des résultats et des conclusions de l'analyse des données de surveillance exposant la justification de toute mesure préventive ou corrective prise et les décrivant

III) ELIMINATION OU RESPONSABILITES ELARGIES DES PRODUCTEURS (REP) – MEDICAMENTS ET DM

RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS (REP)	
Démarches et dispositifs qui restaurent la responsabilité du producteur de produits manufacturés pour ce qui concerne la gestion des déchets finaux ou intermédiaires générés par les produits qu'il a fabriqués ou mis sur le marché pour réduire la production de déchets.	
CADRE REGLEMENTAIRE	• Tout EM de l'UE doit veiller à « la mise en place de systèmes de collecte appropriés pour les médicaments inutilisés ou périmés » • En France, il a été décidé de rendre obligatoire la mise en place d'une filière REP pour la gestion des MNU • Toute pharmacie française a l'obligation de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés, rapportés par les particuliers (sans les emballages en carton)
ORGANISATION DE LA FILIERE	• En France, l'association Cyclamed est à l'origine du dispositif de collecte spécifique des MNU depuis 1993 • Regroupe l'ensemble des acteurs de la profession pharmaceutique ○ Pharmaciens ○ grossistes répartiteurs ○ labos pharmaceutiques (192 en 2014) • Elimination des déchets par incinération
MODALITES DE COLLECTE	

ELIMINATION	
MEDICAMENTS	● Cas de stupéfiants : Les pharmaciens sont les garants de la mise en œuvre de la réglementation en matière de stupéfiants ○ Procédure de dénaturation mise en place par l'Ordre des Pharmaciens ○ Conservation des produits concernés dans une armoire ou un local fermé à clef ○ À l'officine, le pharmacien titulaire doit solliciter le Conseil régional de l'Ordre afin qu'il désigne un pharmacien « témoin » ○ Le pharmacien "demandeur" choisit le procédé de dénaturation le plus adapté pour rendre les produits concernés définitivement inutilisables ○ Procès verbal conservé 10 ans ● Cas de certains patches : destruction par découpage avant incinération avec les ordures ménagères
DM	● L'élimination des DM après utilisation, s'intègre dans la démarche générale de l'élimination des déchets de soins ● La réglementation repose à la fois sur le code de l'environnement et sur la notion de déchet ultime qui y est définie, avec le respect de 4 principes : ○ prévention ou réduction des déchets ○ organisation de leur transport ○ valorisation, recyclage ○ information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique ● Relève : ○ Soit des dispositions spécifiques aux déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI), en particulier pour tous les DM à risque d'accident d'exposition au sang et tous ceux ayant collectés des liquides biologiques potentiellement pathogènes ○ Soit de dispositions spécifiques inhérentes aux produits « toxiques » (mercure, piles, émission de radiations diverses, etc.) ○ Soit des démarches de valorisation pour les DM d'équipements en particulier